

Version française de l'échelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown

E. MOLLARD ⁽¹⁾, J. COTTRAUX ⁽²⁾, M. BOUVARD ⁽³⁾

Résumé. Une traduction et adaptation française de l'échelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown est présentée, faisant référence aux études de validation. Ce nouvel instrument de mesure qui a le mérite d'être synthétique et spécifique représente un progrès et justifierait une étude de validation dans notre pays.

Yale-Brown obsessive compulsive scale : a French version

Summary. A French translation and adaptation of the Yale-Brown obsessive compulsive scale is presented, with reference to validations studies. This new synthetic and specific measurement tool represents an advance and would deserve a French validation study.

Key-words : Obsession-compulsion ; Methodology ; Psychometry.

L'échelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown (Y-BOCS) a été développée par Goodman *et al.* (2, 3). Une version parallèle destinée aux enfants le (CY-BOCS) a également été développée par le même groupe d'auteurs associés à Rapoport. Nous présenterons une traduction et adaptation de la version destinée aux adultes. Elle a jusqu'à présent été utilisée dans trois essais qui étudiaient la fluvoxamine dans les obsessions-compulsions (4-6). Cet instrument de mesure qui se veut global a l'avantage d'arriver après de nombreux autres instruments de mesures, dont il représente une sorte de synthèse, et à une époque où les obsessions suscitent l'intérêt de nombreuses équipes de recherche. Il est en grande partie inspiré par le DSM III-R (1987). L'un de ses avantages est de regrouper des items cognitifs et comportementaux évalués en parallèle selon les mêmes dimensions. Le

Yale-Brown consiste en une échelle de 10 items cotés de 0 à 4 : 5 pour les obsessions, 5 pour les compulsions. Ces 10 items permettent de calculer un score global qui va de 0 à 40. Ils mesurent aussi bien pour les obsessions (idées) que pour, les compulsions (actes rituels) cinq dimensions. A savoir : le temps occupé par les comportements ou les pensées pathologiques, l'interférence avec la vie quotidienne, la détresse, la résistance aux phénomènes pathologiques, et le degré de contrôle exercé sur ceux-ci.

Elle comprend, en outre, neuf autres échelles indépendantes mesurant respectivement la prise de conscience des symptômes, l'évitement, l'indécision, la responsabilisation pathologique, la lenteur, le doute pathologique (ces 5 échelles sont cotées de 0 à 4), la sévérité globale des troubles et l'amélioration globale (tous 2 cotés de 0 à 6), et enfin la fiabilité de l'échelle, cotée de 0 à 3. Ces 9 items additionnels sont considérés pour l'instant comme heuristiques et ne sont pas pris en compte dans les études psychométriques. De plus une « checklist » de symptômes a été ajoutée, ainsi qu'une liste ouverte de 4 symptômes cibles aussi bien pour les obsessions que les compulsions, et un item ouvert d'évitement. Malgré cette apparente complexité, l'instrument de mesure se résume en fait aux dix premiers items qui ont seuls été l'objet d'investigations psychométriques à ce jour.

Le groupe de Goodman est sur le point de publier deux articles (2, 3) qui soulignent la validité des 5 items d'obsessions et des 5 items de compulsions et du score global de l'échelle de Yale-Brown. Dans une étude qui impliquait 4 cotateurs et 40 patients, évalués à différents stades d'un traitement pharmacologique, la fidélité interjuges du score total et de chacun des 10 items s'est avérée excellente ($r < .85$ pour toutes les corrélations). La cohérence interne de l'échelle était également élevée (coefficient alpha de Cronbach = .89).

(1) Docteur en Psychologie.

(2) Psychiatre des Hôpitaux, chargé de cours à l'université Lyon I.

(3) Docteur en Psychologie.

Travail du Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale (Pr J. Guyotat), 59, bd Pinel, 69394 Lyon.

Travail reçu le 26 septembre 1988 et accepté le 4 octobre 1988.

Tirés à part : E. Mollard (à l'adresse ci-dessus).

Avant traitement pharmacologique, si l'on regroupe les données de trois études différentes, le score total de l'échelle de Yale-Brown présentait une corrélation significative avec trois autres mesures indépendantes d'obsession-compulsion : l'échelle globale d'obsession-compulsion du NIMH, et un critère général de sévérité d'obsession-compulsion, l'inventaire d'Obsession-Compulsion du Maudsley, ainsi qu'avec l'échelle de dépression de Hamilton et l'échelle d'anxiété de Hamilton. Ces résultats n'apparaissent constants dans les différents sous-groupes étudiés que pour le critère général et l'échelle globale du NIMH.

L'étude des changements de score après traitement pharmacologique a montré que le score total de l'échelle présentait également une corrélation significative avec l'échelle globale d'obsession-compulsion du NIMH, et un critère général de sévérité d'obsession-compulsion, mais pas avec l'inventaire d'Obsession-Compulsion du Maudsley, l'échelle de dépression de Hamilton, et l'échelle d'anxiété de Hamilton.

L'échelle s'avère sensible aux changements thérapeutiques. Dans une étude comparant fluvoxamine et placebo (4) le score moyen du Yale-Brown était de 25 (écart-type = 6) : un changement statistiquement significatif fut retrouvé, après 8 semaines, pour le groupe traité, mais non pour le groupe placebo. Dans l'étude de Price *et al.* (6) qui n'était pas en double aveugle,

sur 9 sujets les valeurs avant traitement du Yale-Brown étaient de 28 (écart-type = 6), contre 17 (écart-type = 5,6) après traitement ($p < .002$).

Ainsi nous avons à notre disposition un nouvel instrument d'évaluation des obsessions-compulsions qui justifierait une étude de validation sur une population française.

Références

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual, 3rd edition, Revised version (DSM III-R), A.P.A., Washington DC, 1987.
2. GOODMAN W, PRICE H, RASMUSSEN S *et al.* The Yale-Brown obsessive compulsive scale (Y-BOCS). Part I. Development use and reliability. 1988 a (sous presse).
3. GOODMAN W, PRICE H, RASMUSSEN S *et al.* The Yale-Brown obsessive compulsive scale (Y-BOCS). Part II. Validity. 1988 b (sous presse).
4. GOODMAN W, PRICE H, RASMUSSEN S *et al.* Efficacy of Fluvoxamine in obsessive-compulsive disorder. A double-blind comparison with placebo. Arch Gen Psychiatry 1988 c (sous presse).
5. PERSE T, GREIST J, JEFFERSON J *et al.* Fluvoxamine treatment of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1987 ; 144 : 1543-8.
6. PRICE L, GOODMAN W, CHARNEY D *et al.* Treatment of severe obsessive-compulsive disorder with Fluvoxamine. Am J Psychiatry 1987 ; 144 : 1059-61.

ÉCHELLE D'OBSSESSION-COMPULSION DE YALE-BROWN (Y-BOCS).

CONSIGNES POUR L'UTILISATION

L'objectif de cette échelle est de mesurer la gravité et le type des symptômes décrits par les patients souffrant d'obsession-compulsion.

En règle générale, les items sont cotés selon ce que disent les patients. Cependant, c'est le jugement clinique de l'évaluateur qui déterminera le score final. Il s'agit d'évaluer les caractéristiques de chaque item pendant la semaine qui a précédé l'entretien d'évaluation (le temps de l'entretien étant inclus dans l'évaluation). Les scores devront refléter la survenue moyenne de chaque item pour la semaine écoulée.

Cette échelle doit être utilisée sous la forme d'un entretien semi-structuré. L'évaluateur devra évaluer les items dans l'ordre imposé par l'auteur. Cependant, l'évaluateur reste libre de poser des questions supplémentaires s'il souhaite avoir des éclaircissements. Si le patient donne volontiers un certain nombre d'informations au cours de l'entretien, ces dernières seront prises en considération. Les évaluations seront limitées aux éléments d'informations et observations obtenues pendant l'entretien. Si vous estimez que l'information obtenue paraît progressivement inexacte, alors l'honnêteté du patient peut être mise en cause et ceci sera noté à la fin de l'entretien (item 19).

Avant d'engager l'entretien avec les questions donnez au patient une définition des « obsessions » et des « compulsions » comme suit :

- « Les obsessions sont des idées pénibles, des pensées, des images ou des désirs impulsifs qui vous viennent à l'esprit d'une manière répétitive. Elles peuvent vous sembler apparaître contre votre volonté. Vous pouvez aussi les trouver répugnantes, reconnaître qu'elles sont dénuées de sens, ou estimer qu'elles ne correspondent pas du tout à votre personnalité. Elles sont souvent source d'angoisse. »

- « Les compulsions, d'un autre côté, sont des comportements ou des actes que vous vous sentez obligé d'accomplir, même si vous les reconnaissez comme dénués de sens ou excessifs. Parfois, vous essayez de résister et de ne pas les faire, mais ceci s'avère souvent difficile. Vous pouvez ressentir une anxiété qui ne diminuera pas, tant que l'acte n'est pas accompli. »

Je vais vous donner quelques exemples d'obsessions-compulsions :

« Un exemple d'obsession serait la pensée récurrente ou le désir impulsif de faire gravement mal physiquement à vos enfants, même si vous ne l'aviez jamais voulu. »

« Un exemple de compulsion serait le besoin de vérifier le verrou de la porte d'entrée six fois avant de pouvoir quitter la maison. Si la plupart des compulsions sont des comportements observables, d'autres sont des actes mentaux inobservables comme une vérification silencieuse, ou la nécessité de répéter des phrases qui n'ont pas de sens pour vous, chaque fois que vous avez une mauvaise pensée. »

« Avez-vous des questions à poser sur le sens de ces deux mots ? (si non, continuez). »

En cas de mesures répétées, il n'est pas nécessaire de donner à nouveau ces définitions et ces exemples au patient dans la mesure où l'on est sûr qu'il les a bien compris. Il peut être suffisant de lui rappeler que les obsessions sont des pensées et les compulsions des actes, que l'on se sent obligé de faire, actes ou rituels mentaux.

Demandez au patient d'énumérer les obsessions et les compulsions qu'il a couramment afin d'établir une liste de symptômes cibles. Utilisez la « *checklist* » des obsessions compulsions (voir Annexe 1) pour vous aider à identifier les symptômes actuels. Il est

Suite de l'échelle p. 337

Suite de l'échelle d'obsession-compulsion de Yale-Brown

également utile de bien identifier des symptômes anciens dans la mesure où ils peuvent apparaître lors d'évaluations ultérieures. Après avoir identifié les obsessions et les compulsions, ordonnez-les sur la feuille répertoriant les *symptômes cibles* (Annexe 2) en fonction de critères cliniques facilement discernables (par exemple, répartissez les compulsions cibles en vérification et lavage). Notez les éléments pertinents des symptômes afin qu'il puissent être plus facilement repérés (par exemple, quand on répertorie les vérifications, spécifiez ce que le patient vérifie). Assurez-vous bien de noter les symptômes les plus importants, par exemple, ceux qui feront l'objet principal de l'évaluation. De toute façon, le score final pour chaque item devra refléter une évaluation composite de l'ensemble des obsessions et des compulsions du patient.

En cas d'évaluations répétées, revoyez les obsessions cibles et éventuellement modifiez-les avant de coter l'item 1, faites de même pour les compulsions avant de coter l'item 6.

Les 19 items sont cotés, mais seuls les items 1 à 10 sont utilisés pour déterminer le score total. Ce score total de l'échelle Y-BOCS (somme des items 1 à 10) est composé respectivement du sous-total des obsessions (items 1 à 5) et du sous-total des compulsions (items 6 à 10).

1) DURÉE DES PENSÉES OBSÉDANTES

Q : Combien de temps durent les pensées obsédantes ?

Lorsque les obsessions surviennent d'une manière intrusive, brève et intermittente, il est parfois impossible d'évaluer leur durée en termes d'heures. Dans ce cas, estimez la durée en fonction de la fréquence de leur survenue. Prenez aussi bien en considération la fréquence de la survenue de la pensée, que le nombre d'heures dans la journée qui sont affectées par cette pensée.

Demandez : « Combien de fois la pensée obsédante arrive-t-elle ? Assurez-vous d'exclure les ruminations et les préoccupations qui, contrairement aux obsessions, sont égo-syntoniques et rationnelles (mais exagérées). »

- 0 : Nulle.
- 1 : Légère (moins d'1 h par jour) ou survenue occasionnelle (pas plus de 8 fois par jour).
- 2 : Moyenne (1 à 3 h par jour) ou survenue fréquente (plus de 8 fois par jour, mais la journée se passe la plus grande partie du temps sans obsession).
- 3 : Importante (plus de 3 h par jour, jusqu'à 8 h par jour) ou survenue très fréquente (plus de 8 fois par jour et occupant une très grande partie de la journée).
- 4 : Extrêmement importante (supérieure à 8 h par jour, ou envahissement pratiquement constant) ; pensées tellement nombreuses que l'on ne peut les compter et il est très rare de passer 1 h dans la journée sans que plusieurs pensées ne surviennent.

2) GÊNE LIÉE AUX PENSÉES OBSÉDANTES

Q : Dans quelle mesure vos pensées obsédantes vous gênent-elles dans votre vie sociale ou professionnelle ? Y a-t-il des choses qu'il vous est impossible de faire à cause de ces pensées obsédantes (si actuellement le patient ne travaille pas, essayez d'évaluer de combien sa performance serait amoindrie si il travaillait).

- 0 : Nulle.
- 1 : Légère, faible gêne dans les activités sociales ou professionnelles mais l'efficacité globale du patient n'est pas altérée.
- 2 : Moyenne, nette gêne dans les activités sociales et professionnelles mais le patient peut encore faire face.
- 3 : Importante, cause une altération réelle des activités sociales et professionnelles du patient.
- 4 : Extrêmement importante : gêne invalidante.

3) ANGOISSE ASSOCIÉE AUX PENSÉES OBSÉDANTES

Q : Quel niveau d'angoisse ces pensées obsédantes créent-elles en vous ?

(Dans la plupart des cas, l'angoisse est synonyme d'anxiété. Cependant des patients peuvent trouver leurs obsessions « gênantes » mais nier « l'anxiété ». Ne cotez ici que l'anxiété qui semble déclenchée par les obsessions, non pas l'anxiété généralisée ou l'anxiété liée à d'autres symptômes).

- 0 : Nulle.
- 1 : Légère, rare et très peu gênante.
- 2 : Moyenne, fréquente et gênante, mais que le patient gère encore assez bien.
- 3 : Importante, très fréquente et très gênante.
- 4 : Extrêmement importante, pratiquement constante et d'une gêne invalidante.

4) RÉSISTANCE AUX PENSÉES OBSÉDANTES

Q : Quel effort fournissez-vous pour résister aux pensées obsédantes ? Essayez-vous souvent de détourner votre attention de ces pensées quand elles vous viennent à l'esprit ? (n'évaluez ici que l'effort fourni par le patient pour résister, pas le succès ou l'échec dans le contrôle effectif des obsessions). L'effort fourni par un patient pour résister à ses pensées obsédantes peut ou non correspondre à sa capacité à les contrôler. Cet item n'est pas une mesure directe de la teneur des pensées qui surviennent, il mesure plutôt la manifestation de quelque chose de sain, à savoir, l'effort fourni par le patient pour contrecarrer les obsessions. Ainsi, plus un patient essaie de résister, moins cet aspect de son fonctionnement paraîtra altéré. Si les obsessions sont très réduites, le patient peut ne pas éprouver le besoin de leur résister. Dans ce cas on donnera la cote « 0 ».

- 0 : Fait l'effort de toujours résister, ou symptômes si minimes qu'ils ne nécessitent pas qu'on leur résiste.
- 1 : Essaie de résister la plupart du temps.
- 2 : Fait quelque effort pour résister.
- 3 : Cède à toutes les obsessions, sans essayer de les contrôler, mais est quelque peu contrarié de ne pouvoir mieux faire.
- 4 : Cède volontiers et totalement à toutes les obsessions.

5) DEGRÉ DE CONTRÔLE SUR LES PENSÉES OBSÉDANTES

Q : Quel contrôle exercez-vous sur vos pensées obsédantes ? Dans quelle mesure arrivez-vous à stopper ou à détourner vos pensées obsédantes ? (contrairement à l'item précédent sur la résistance, la capacité du patient à contrôler ses obsessions est plus directement liée à l'importance des pensées qui surviennent).

- 0 : Contrôle total.
- 1 : Beaucoup de contrôle ; généralement capable de stopper ou de détourner les obsessions avec quelques efforts et de la concentration.
- 2 : Contrôle moyen, peut de temps en temps arriver à stopper ou à détourner ses obsessions.
- 3 : Peu de contrôle, arrive rarement à stopper ses obsessions, peut seulement détourner son attention avec difficulté.
- 4 : Pas de contrôle, semble totalement dépourvu de volonté, rarement capable de détourner son attention de ses obsessions, même momentanément.

6) DURÉE DES RITUELS

Q : Combien de temps passez-vous à faire des rituels ? Lorsque ce sont des rituels incluant des activités concernant la vie de tous les jours qui sont principalement présents, demandez : Combien de temps vous faut-il de plus qu'à la majorité des gens pour accomplir les activités quotidiennes, du fait de vos rituels ? Lorsque les compulsions se présentent comme des comportements brefs, intermittents, il peut paraître impossible d'évaluer le temps passé à les émettre, en termes d'heures. Dans ce cas, estimez la durée en déterminant la fréquence de leur émission. Considérez aussi bien le nombre de fois où les compulsions sont émises que le nombre d'heures par jour parasitées par ces compulsions.

Suite de l'échelle pp. 338, 339

Notez le nombre de fois où le comportement compulsif apparaît, et non pas les répétitions ; par exemple, un patient qui va dans la salle de bain 20 fois par jour, à différents moments de la journée pour se laver les mains 5 fois de suite très rapidement, émet des rituels 20 fois par jour, pas 5 fois, ni 100 fois (20 x 5).

Demandez : quelle est la fréquence de vos rituels ? Dans la plupart des cas les rituels sont des comportements observables (par exemple, lavage des mains) mais il y a des cas où les compulsions ne sont pas observables (par exemple, des vérifications mentales).

0 : Nulle.

1 : Légère (passe moins d'1 h à faire des rituels ou émission occasionnelle de conduites ritualisées pas plus de 8 fois par jour).

2 : Moyenne (passe de 1 h à 3 h par jour à faire des rituels), ou apparition fréquente des conduites ritualisées (plus de 8 fois par jour, mais le temps, en majorité, n'est pas envahi par les compulsions).

3 : Importante (passe plus de 3 h et jusqu'à 8 h par jour à faire des rituels) ou apparition très fréquente des conduites ritualisées (plus de 8 fois par jour ; la plupart du temps est pris par les compulsions).

4 : Extrêmement importante (passe plus de 8 h par jour à faire des rituels) ou présence pratiquement constante de conduites ritualisées (trop importantes pour être dénombrées ; une heure se passe rarement sans qu'apparaissent plusieurs compulsions).

7) GÊNE LIÉE AUX RITUELS

Q : Dans quelle mesure les rituels vous gênent-ils dans votre vie sociale ou professionnelle ? Y a-t-il des choses qu'il vous est impossible de faire à cause de vos rituels ? (si actuellement le patient ne travaille pas, essayez d'évaluer de combien sa performance serait amoindrie s'il tenait son emploi).

0 : Nulle.

1 : Légère, faible gêne dans les activités sociales ou professionnelles, mais l'efficacité globale du patient n'est pas altérée.

2 : Moyenne, nette gêne dans les activités sociales ou professionnelles, mais le patient peut faire face.

3 : Importante, cause une altération réelle des activités sociales ou professionnelles du patient.

4 : Extrêmement importante, gêne invalidante.

8) ANGOISSE ASSOCIÉE AUX RITUELS

Q : Comment vous sentiriez-vous si l'on vous empêchait de faire votre (vos) rituel(s) ? (pause) Seriez-vous très anxieux ? Évaluez le degré d'angoisse du patient si l'exécution du rituel était soudainement interrompue, sans réassurance en contre partie. Dans la plupart des cas, mais pas dans tous, le fait de ritualiser réduit l'anxiété. Si, d'après le jugement de l'évaluateur, l'anxiété est effectivement réduite, quand on empêche le patient de faire ses rituels comme décrit ci-dessus, alors demandez : donnez-nous un indice de votre anxiété, pendant que vous faites les rituels jusqu'au moment où satisfait, vous cessez.

0 : Nulle.

1 : Légère, seulement légèrement anxieux si on l'empêche de ritualiser ou seulement une légère anxiété pendant l'accomplissement des rituels.

2 : Moyenne, dit que l'angoisse monterait mais resterait contrôlable si on l'empêchait de ritualiser, ou que l'anxiété augmente mais reste contrôlée pendant qu'il accomplit ses rituels.

3 : Importante, augmentation très nette et très éprouvante de l'anxiété si les rituels sont interrompus, ou augmentation très nette et très éprouvante de l'anxiété pendant l'accomplissement des rituels.

4 : Extrêmement importante, anxiété invalidante dès qu'une intervention vise à modifier l'activité ritualisée ou anxiété invalidante pendant l'accomplissement des rituels.

9) RÉSISTANCE AUX COMPULSIONS

Q : Quel effort fournissez-vous pour résister aux compulsions ? N'évaluez ici que l'effort fourni pour résister, pas le succès ou l'échec dans le contrôle effectif des rituels. L'effort du patient pour résister à ses rituels peut ou non correspondre à sa capacité à les contrôler. Cet item n'est pas une mesure directe de gravité des rituels. Il évalue plutôt la manifestation de quelque chose de sain, à savoir, l'effort fourni par le patient pour contre-carrer les rituels.

Ainsi plus le patient essaie de résister, moins cet aspect de son fonctionnement paraîtra altéré. Si les rituels sont très réduits, le patient peut très bien ne pas éprouver le besoin de leur résister. Dans ces cas, on donnera la cote 0.

0 : Fait l'effort de toujours résister, ou symptômes si minimes qu'ils ne nécessitent pas qu'on leur résiste.

1 : Essaie de résister la plupart du temps.

2 : Fait quelques efforts pour résister.

3 : Cède à tous les rituels, sans essayer de les contrôler, mais est quelque peu contrarié de ne pouvoir mieux faire.

4 : Cède volontiers et totalement à tous les rituels.

10) DEGRÉ DE CONTRÔLE SUR LES RITUELS

Q : Quelle est l'intensité de la pulsion qui vous oblige à ritualiser ? (pause). Quel contrôle pouvez-vous exercer sur les rituels ? (contrairement à l'item précédent sur la résistance, la capacité du patient à contrôler ses compulsions est plus directement liée à l'importance des compulsions).

0 : Contrôle total.

1 : Beaucoup de contrôle. Ressent une certaine obligation à accomplir les rituels, mais peut généralement exercer un contrôle volontaire sur cette pression.

2 : Contrôle moyen, forte obligation à accomplir les rituels, peut la contrôler, mais avec difficulté.

3 : Peu de contrôle. Très forte obligation à accomplir des rituels. Doit aller jusqu'au bout de l'activité ritualisée, ne peut différer qu'avec difficulté.

4 : Aucun contrôle, l'obligation à accomplir les rituels est vécue comme complètement involontaire et irrésistible, ne peut que rarement différer même momentanément l'activité.

11) CAPACITÉ À S'INTERROGER SUR LES OBSESSIONS ET LES COMPULSIONS

Q : Pensez-vous que vos pensées ou comportements sont raisonnables ? (pause). Que pensez-vous qu'il arriverait si vous n'accomplissiez pas vos rituels ? Êtes-vous persuadé que quelque chose arriverait ? (Évaluez la capacité du patient à percevoir l'aspect excessif ou absurde de ses obsessions fondées sur les croyances exprimées au moment de l'entretien).

0 : Excellente capacité de réflexion. Tout à fait rationnel.

1 : Bonne capacité de réflexion. Reconnaît très vite l'aspect absurde ou excessif de ses pensées ou de ses comportements, mais ne semble pas totalement convaincu que seule l'anxiété soit uniquement associée à ce comportement.

2 : Faible capacité de réflexion. A du mal à admettre que ses pensées ou comportements sont absurdes ou excessifs, mais peut douter. Peut avoir des pensées irréalistes, mais pas de convictions fermes.

3 : Capacité de réflexion pauvre. Maintient que les pensées ou les comportements ne sont ni absurdes, ni excessifs.

4 : Absence d'auto-critique, toute puissance de la pensée. Absolument convaincu que ses pensées et comportements sont rationnels. Incapable d'entendre des arguments contradictoires.

12) ÉVITEMENT

Q : Vous est-il arrivé d'éviter de faire certaines choses, d'aller quelque part, ou d'être avec quelqu'un, du fait de vos pensées obsédantes ou par peur d'émettre des rituels ? (si oui, alors demandez). Quelle est l'importance de cet évitement ? Évaluez à quel point le patient a tendance à éviter délibérément de faire quelque chose. Parfois, des compulsions ont pour effet d'évi-

impulsion de Yale-Brown

ter » le contact avec des choses que le patient redoute. Par exemple, on dirait que les compulsions à laver des vêtements sont des rituels, non des conduites d'évitement. Mais si le patient refuse de s'occuper de la lessive, alors ceci serait une conduite d'évitement.

- 0 : Pas d'évitement délibéré.
- 1 : Évitement minimal.
- 2 : Évitement moyen. Évitement net mais limité.
- 3 : Évitement important. L'évitement est un comportement dominant.
- 4 : Évitement extrême et très élargi : le patient fait tout ce qu'il peut pour éviter de déclencher les symptômes.

13) DEGRÉ D'INDÉCISION

Q : Éprouvez-vous des difficultés à prendre des décisions à propos de problèmes mineurs qui ne demanderaient qu'un temps très bref de réflexion à la plupart des gens (par exemple : comment s'habiller le matin ?) (Il ne faut pas considérer ici la difficulté à prendre des décisions, du fait d'une tendance à ruminer. Par ailleurs, l'ambivalence dans les choix rendus difficiles par des aspects rationnels ne doit pas non plus être prise ici en considération).

- 0 : Aucune.
- 1 : Légère. Quelques difficultés à prendre des décisions à propos de problèmes mineurs.
- 2 : Moyenne. Rapporte spontanément une difficulté significative à prendre des décisions, comparée au temps de réflexion que cette même décision prendrait à d'autre personne.
- 3 : Importante. Pèse continuellement le pour et le contre pour des problèmes très secondaires.
- 4 : Extrêmement importante, incapable de prendre la moindre décision. Indécision invalidante.

14) SURESTIMATION DU SENS DES RESPONSABILITÉS

Q : Avez-vous tendance à vous reprocher la survenue d'événements qui ne sont pas complètement sous votre contrôle ? Vous sentez-vous très responsable de ce qui arrive aux autres ?

- 0 : Pas du tout.
- 1 : Légèrement, ceci est mentionné uniquement si l'on interroge le patient à ce sujet. Léger sentiment d'une haute responsabilité.
- 2 : Moyennement, idées de responsabilité clairement présentes et spontanément développées par le patient. Sens élevé de sa responsabilité pour des événements survenus, au-delà de ce qu'il pouvait raisonnablement contrôler.
- 3 : Importante, idées dominantes et envahissantes de sa responsabilité, profondément convaincu qu'il est responsable d'événements survenus nettement au-delà de ce qu'il pouvait raisonnablement contrôler. Auto-accusation, culpabilisation, à la limite de l'irrationnel.
- 4 : Extrêmement importante, sens abusif des responsabilités, à la limite de l'hallucination (exemple : si un tremblement de terre se produit à 5 000 km, le patient se sentira coupable et se reprochera de ne pas avoir fait ses rituels).

15) LENTEUR GÉNÉRALE – GÊNE LIÉE A L'INERTIE

Q : Est-il difficile pour vous de démarrer ou d'achever une activité, du fait de votre souci perfectionniste ? Est-ce que beaucoup de tâches routinières vous prennent plus de temps pour les faire, qu'elles ne le nécessiteraient ? (ne pas confondre avec le ralentissement psychomoteur secondaire à une dépression. Évaluez le surcroît de temps passé à faire des activités routinières même si l'on n'identifie pas véritablement d'obsessions spécifiques).

- 0 : Nulle.
- 1 : Légère, latence occasionnelle pour démarrer ou finir une activité.
- 2 : Moyenne, prolongation fréquente des activités routinières, mais en général les tâches sont achevées ; souvent en retard.
- 3 : Importante, difficulté nette et généralisée pour démarrer et pour terminer des activités routinières. Presque toujours en retard.
- 4 : Extrêmement importante, incapable de démarrer ou d'achever des tâches routinières sans une assistance totale.

16) DOUTE PATHOLOGIQUE

Q : Avez-vous l'impression de ne pas faire confiance à votre mémoire, ou de ne pas être sûr(e) de vos perceptions (par exemple, douter de ce vous voyez, entendez ou touchez) ? Êtes-vous très gêné(e) par le fait de douter de vous-même ?

- 0 : Pas du tout.
- 1 : Léger, mentionné uniquement si l'on pose la question, faible sentiment de douter de soi.
- 2 : Moyen, ces idées sont exprimées spontanément, sont nettement présentes. Le patient est gêné par un doute de soi important. Des effets certains sur les performances du patient, mais il peut encore assez bien faire face.
- 3 : Important, l'incertitude au niveau des perceptions ou de la mémoire est dominante. Le doute de soi affecte très souvent les performances.
- 4 : Extrêmement important, l'incertitude sur les perceptions est constamment présente ; le doute de soi affecte pratiquement toutes les activités. Doute invalidant (par exemple le patient dit : « mon cerveau ne croit pas ce que mes yeux voient »).

17) GRAVITÉ GLOBALE*

Q : Appréciation de la gravité de la maladie du patient par l'interviewer. Évaluer de 0 (pas de problème) à 6 (patient le plus grave, parmi ceux que l'on a pu voir). (Considérer ici le degré d'angoisse rapportée par le patient, les symptômes observés et la perturbation apportée dans la vie du patient. L'appréciation tiendra compte à la fois d'une évaluation moyenne de ces données et de la véracité ou de la justesse des informations obtenues. Cette appréciation devra être fondée à partir des informations, obtenues au cours de l'entretien).

- 0 : Aucun problème.
- 1 : Très léger problème, à la limite de la normale, aspect très occasionnel, aucune gêne dans la vie du patient.
- 2 : Symptômes légers, légère gêne dans la vie du patient.
- 3 : Symptômes moyennement importants. Le patient doit faire des efforts pour faire face à ses activités quotidiennes.
- 4 : Symptômes plus gravement importants. Le patient est limité dans ses activités quotidiennes.
- 5 : Symptômes graves, le patient doit être le plus souvent assisté dans ses activités quotidiennes.
- 6 : Symptômes extrêmement graves, le patient est complètement invalidé.

18) AMÉLIORATION GLOBALE*

Q : Évaluez l'amélioration globale actuelle – depuis le début de l'évaluation – que cette amélioration soit ou non due à votre avis, au traitement.

- 0 : Très nettement aggravé.
- 1 : Nettement aggravé.
- 2 : Légèrement aggravé.
- 3 : Pas de changement.
- 4 : Légèrement amélioré.
- 5 : Nettement amélioré.
- 6 : Très nettement amélioré.

19) FIABILITÉ

Q : Évaluez la fiabilité globale des scores obtenus. Parmi les facteurs qui peuvent affecter la fiabilité, seront incluses la collaboration du patient et sa facilité naturelle à communiquer. Le type et la gravité des symptômes obsessionnels présentés par le patient peuvent avoir une influence sur sa concentration, son attention ou sa liberté à s'exprimer spontanément (par exemple, certaines obsessions dans leur contenu, peuvent amener le patient à choisir son vocabulaire d'une manière particulièrement soignée).

- 0 : Excellente, aucune raison de suspecter les données.
- 1 : Bonne, présence de facteurs qui peuvent affecter défavorablement la fiabilité des données.
- 2 : Légère, présence de facteurs qui réduisent nettement la fiabilité des données.
- 3 : Pauvre, données très peu fiables.

* Les items 17 et 18 sont adaptés de « The clinical Global Impression Scale ». Guy W. Edeu. Assessment Manual for Psychopharmacology - Publication 76-338 Washington, DC US Department of Health, Education and Welfare 1976.

ANNEXE 1. — LISTE DES OBSESSIONS ET COMPULSIONS.

Nom du patient	Date	Nom du patient	Date
OBSESSIONS A THÈME AGRESSIF		OBSESSIONS DIVERSES	
	<i>Actuelle Passée</i>		<i>Actuelle Passée</i>
- Peur de faire du mal aux autres - Peur de se faire du mal - Images de violence ou d'horreur - Peur de laisser échapper des obsénités ou des insultes - Peur de faire quelque chose qui met dans l'embarras - Peur d'agir sous d'autres impulsions (par exemple, de voler une banque, de voler à l'étalage, d'être malhonnête avec une caissière) - Peur d'être responsable de ce qui va mal (par exemple, la compagnie va faire faillite à cause du patient) - Peur que quelque chose de terrible puisse arriver (par exemple, le feu, un cambriolage, la mort ou la maladie d'un patient ou d'un ami ; superstitions diverses) - Autres		- Besoin de savoir ou de se souvenir - Peur de dire certaines choses - Peur de ne pas dire exactement ce qu'il faut - Images parasites (neutres) - Sons, mots ou musiques parasites et dénués de sens - Nombres qui portent bonheur ou non - Attribution de significations spéciales aux couleurs - Autres	
OBSESSIONS DE CONTAMINATION		OBSESSIONS COMPULSIONS SOMATIQUES	
- Angoisse ou dégoût lié aux déchets ou aux sécrétions corporels (par exemple l'urine, les selles, la salive) - Angoisse liée à la saleté ou aux microbes - Angoisse excessive liée aux éléments contaminants dans l'environnement (par exemple, l'amiante, les radiations, les déchets toxiques) - Angoisse excessive liée aux éléments touchant la maison (par exemple, les détergents, les solvants, les animaux familiers) - Angoisse à l'idée d'être malade - Angoisse à l'idée de provoquer une maladie chez les autres (agressivité) - Autres		COMPULSIONS DE LAVAGE/NETTOYAGE	
OBSESSIONS SEXUELLES		COMPULSIONS AYANT POUR THÈME LE FAIT DE COMPTER	
- Impulsions, images ou pensées perverses ou interdites à propos de la sexualité - Le contenu a trait à des enfants - Le contenu a trait à des animaux - Le contenu a trait à l'homosexualité - Comportement sexuel envers les autres (agressivité) - Autres		COMPULSIONS DE VÉRIFICATION	
OBSESSIONS DE COLLECTION, D'ACCUMULATION		- Vérifier les portes, les serrures, la cuisinière, les appareils ménagers, le frein à main dans la voiture, etc. - Vérifier que rien ne risque de faire du tort aux autres - Vérifier que rien ne risque de faire du tort à soi-même - Vérifier que rien ne puisse être contaminant - Autres vérifications	
OBSESSIONS RELIGIEUSES		RITUELS DE RÉPÉTITION	
OBSESSIONS DE SYMÉTRIE, D'EXACTITUDE, D'ORDRE		- Sortir/entrer – se lever/s'asseoir, etc. - Autres	
		COMPULSIONS D'ORDRE/DE RANGEMENT	
		COMPULSIONS DE COLLECTION	
		COMPULSIONS DIVERSES	
		- Rituels mentaux (autres que vérifier ou compter) - Besoin de dire, de demander, de confesser... - Besoin de toucher - Mesures : pour s'empêcher : de se faire du mal de faire du mal aux autres pour éviter qu'il y ait des conséquences catastrophiques - Autres	

ANNEXE 2. — SYMPTÔMES CIBLES.

Nom du patient :		Date :	
Obsessions			
Problème 1 :	Problème 3 :		
Problème 2 :	Problème 4 :		
Compulsions			
Problème 1 :	Problème 3 :		
Problème 2 :	Problème 4 :		
Évitement			

ÉCHELLE D'OBSESSION COMPULSION DE YALE-BROWN (Y-BOCS).

Nom du patient	Score total Y-BOCS (additionner les items 1 à 10)				
	Date : Évaluateur :				
	<i>Nul</i>	<i>Un peu</i>	<i>Moyen</i>	<i>Important</i>	<i>Extrêmement important</i>
1 - Temps passé aux obsessions	0	1	2	3	4
2 - Gêne liée aux obsessions	0	1	2	3	4
3 - Angoisse associée aux obsessions	0	1	2	3	4
	<i>Résiste totalement</i>				<i>Cède complètement</i>
4 - Résistance	0	1	2	3	4
	<i>Contrôle total</i>	<i>Beaucoup de contrôle</i>	<i>Contrôle moyen</i>	<i>Peu de contrôle</i>	<i>Pas de contrôle</i>
5 - Contrôle sur les obsessions	0	1	2	3	4
Sous-total obsessions (additionner les items 1 à 5)					
	<i>Nul</i>	<i>Un peu</i>	<i>Moyen</i>	<i>Important</i>	<i>Extrêmement important</i>
6 - Temps passé aux compulsions	0	1	2	3	4
7 - Gêne liée aux compulsions	0	1	2	3	4
8 - Angoisse associée aux compulsions	0	1	2	3	4
	<i>Résiste totalement</i>				<i>Cède complètement</i>
9 - Résistance	0	1	2	3	4
	<i>Contrôle total</i>	<i>Beaucoup de contrôle</i>	<i>Contrôle moyen</i>	<i>Peu de contrôle</i>	<i>Pas de contrôle</i>
10 - Contrôle sur les compulsions	0	1	2	3	4
Sous-total compulsions (additionner les items 6 à 10)					
	<i>Excellente</i>				<i>Absente</i>
11 - Prise de conscience des problèmes obsessifs-compulsifs	0	1	2	3	4
	<i>Nul</i>	<i>Un peu</i>	<i>Moyen</i>	<i>Important</i>	<i>Très important</i>
12 - Évitement	0	1	2	3	4
13 - Indécision	0	1	2	3	4
14 - Responsabilité pathologique	0	1	2	3	4
15 - Lenteur	0	1	2	3	4
16 - Doute pathologique	0	1	2	3	4
17 - Sévérité globale du problème	0	1	2	3	4 5 6
18 - Amélioration globale	0	1	2	3	4 5 6
	<i>Excellente</i>	<i>Bonne</i>	<i>Légère</i>	<i>Pauvre</i>	
19 - Fiabilité	0	1	2	3	